

“CONDUCTAS SEXUALES ABUSIVAS ENTRE NIÑOS Y ADOLESCENTES: EVALUACIÓN, INTERVENCIÓN Y PERSPECTIVA FORENSE”

Lic. Mauricio Berón –Facultad de Psicología – UDELAR
Psicólogo Judicial y Forense.
Especialista en Evaluación Psicológica Clínica (UDELAR).
Especialista en Psicología en Servicios de Salud (UDELAR).
Diplomado en Psicología Forense
Diplomado en Perfilación Criminal
Diplomado en Victimología

Sábado 22 de noviembre | 9:00 a 12:00 hs (Uruguay)

Objetivo General

- Brindar herramientas técnicas, clínicas y éticas para **comprender, evaluar e intervenir** en situaciones de **conductas sexuales abusivas o distorsionadas entre pares**, tanto en contextos educativos como terapéuticos y judiciales.

DIFERENCIAS ENTRE EXPLORACIÓN SEXUAL INFANTIL Y CONDUCTAS SEXUALIZADAS PROBLEMÁTICAS (CSP)

La exploración sexual infantil: un fenómeno evolutivo, no patológico

La exploración sexual infantil forma parte del camino natural del desarrollo psicosexual.

Los niños, desde muy temprana edad, buscan comprender cómo funciona su cuerpo y el de los demás. Lo hacen de manera espontánea, ingenua y sin intencionalidad sexual adulta.

CURIOSIDAD GENUINA: UN MOVIMIENTO HACIA EL DESCUBRIMIENTO DEL PROPIO CUERPO

**En la infancia, la sexualidad no es una búsqueda erótica, sino una
forma de conocimiento.**

Los niños exploran del mismo modo en que exploran juguetes, texturas o sonidos: a través del tacto, la mirada y el juego.

La curiosidad sexual infantil saludable se expresa en:

- Preguntas inocentes sobre diferencias anatómicas.
- Juegos de “¿cómo somos por dentro?” o “¿por qué vos tenés eso y yo no?”.
- Interés por nombrar partes del cuerpo sin vergüenza ni erotización.

Aquí no hay intención de excitar, dominar ni reproducir escenas adultas.

Hay curiosidad por comprender, tal como un niño se pregunta por qué el cielo es azul o cómo llega un bebé a la panza de la madre.

El niño no busca sexo. Busca respuestas.

**Simetría evolutiva y relacional: entre iguales, todo se
regula con el juego**

La exploración saludable ocurre entre niños que comparten:

- Edad similar
- Nivel cognitivo y emocional semejante
- Curiosidad recíproca

La simetría permite que el juego:

- Sea negociado
- Pueda interrumpirse sin conflicto
- **No genere angustia**
- No incluya dominancia ni presión

Los niños se ríen, se miran, se sorprenden... pero no se esconden, no se avergüenzan de manera intensa, no fuerzan situaciones.

En un marco forense:

- La simetría es un indicador clave de normalidad.
- Ausencia de **coerción, manipulación o angustia**

La exploración infantil no requiere:

- Engaño
- Secreto
- Amenazas
- Presión
- Manipulación Emocional

Si aparece alguno de estos factores, ya no estamos frente a un juego exploratorio, sino ante un indicio de CSP.

En la exploración esperable:

- Nadie obliga a “ver”, “tocar” o “mostrar”.
- Si uno no quiere, el juego se detiene.
- No existe la idea de “si contás te va a pasar algo”.

La ausencia de angustia permite diferenciar una conducta espontánea de una dinámica problemática.

Un niño puede mostrarse curioso, nunca asustado.

Temporalidad acotada: la conducta aparece y se desvanece

EL JUEGO EXPLORATORIO:

- Es episódico
- Breve

- **No se repite compulsivamente**

El niño satisface su curiosidad y continúa jugando con otra cosa.

Cuando la conducta aparece una y otra vez, de manera rígida u obsesiva, suele indicar:

- **Exposición Inapropiada**
- **Trauma Previo**
- **Tensión Emocional**
- **Repetición de escenas adultas internalizadas**

La repetición es una señal pericial: habla de algo que insiste porque no fue simbolizado.

Se integra dentro del juego simbólico

La exploración infantil saludable forma parte de un contexto lúdico mayor:

- Jugar al médico, a las familias, a los superhéroes, etc.
- **El interés por el cuerpo aparece como un elemento más del juego, no como el protagonista central.**

Es decir:

- Se enmarca en historias
- Tiene principio y fin
- No se aísla del juego global
- No genera ansiedad ni tensión

En términos narrativos:

- El cuerpo aparece como personaje del juego simbólico, no como objeto sexual.

Cuando la conducta deja de ser exploración y pasa a ser CSP

Las conductas sexualizadas problemáticas emergen cuando la conducta:

- Desborda lo evolutivo y adquiere un matiz disruptivo
- La conducta “aparece” como algo que no corresponde al nivel madurativo del niño. Distorsiona el juego, interrumpe la espontaneidad infantil, invade el espacio relacional.

Indicadores clínicos y forenses clave:

1. Repetición compulsiva o temática fija

Las conductas se repiten idénticas, tienen un guion rígido, dominan el juego y son difíciles de redireccionar

Esto habla de memoria traumática, no de curiosidad.

2. Conocimiento sexual no acorde a la edad

Un niño que: simula sexo oral, reproduce posiciones sexuales, imita sonidos o movimientos de adultos y busca penetración, no está explorando.

Está replicando escenas internas que no corresponden a su desarrollo.

Esto siempre exige indagación clínica y forense.

3. Búsqueda explícita de estimulación sexual

Aparece búsqueda de:

- Frotamiento repetido
- Excitación genital
- Exposición compulsiva
- Masturbación intrusiva o pública

Aquí la conducta tiene una carga que excede lo simbólico y se vuelve descarga.

4. Asimetrías de poder

Cuando uno: es mayor, tiene más fuerza, decide las reglas, controla la situación domina emocional o socialmente, la conducta ya no es un juego: **es una situación de riesgo.**

5. Uso de amenazas, presión, manipulación o secreto

Si aparece: “no digas nada porque...” “si no querés, te obligo...”

“no se lo cuentes a mamá”. **La dinámica ya es coercitiva.**

Estas marcas son cruciales para el análisis clínico y pericial, y nunca deben minimizarse.

6. Angustia en alguno de los niños involucrados

El síntoma emocional guía el análisis:

- Llanto
- Retraimiento
- Evitación
- Miedo
- Sexualización en otros contextos
- Regresiones

La angustia es un criterio diferencial contundente.

MIRADA PSICO FORENSE

El propósito de este módulo es que el profesional aprenda a leer la conducta sexualizada como un síntoma, no como un delito en sí mismo ni como una patología intrínseca del niño.

La conducta sexualizada es:

- Un lenguaje
- Una manifestación

- Un acto simbólico o traumático
- Un desborde del sistema nervioso
- Una repetición de memoria implícita
- Una búsqueda de regulación

Es la punta del iceberg.

Debajo, casi siempre encontramos:

- TRAUMA PREVIO
- EXPOSICIÓN SEXUAL INAPROPIADA
- NEGLIGENCIA EMOCIONAL
- DESREGULACIÓN AFECTIVA
- AUSENCIA DE LÍMITES ESTRUCTURANTES
- MODELOS ADULTOS DISRUPTIVOS

En la práctica forense:

“No se evalúa la conducta aislada: se evalúa la historia que la conducta está contando.”

CONDUCTAS ABUSIVAS ENTRE PARES

Una mirada clínica–forense para comprender lo que ocurre cuando un niño cruza el umbral del juego hacia el daño.

Conductas de abuso entre niños y preadolescentes

Las conductas abusivas entre pares no comienzan con violencia explícita: **comienzan con un quiebre en la simetría del vínculo.**

Un niño toma un rol de dominio, otro queda en posición de sometimiento. Ese quiebre es la marca del abuso.

¿Cómo se expresan estas conductas en la infancia y pre adolescencia?

A diferencia del adulto, el niño que ejerce conductas abusivas no necesariamente comprende la gravedad del acto, pero sí comprende el poder que ejerce:

- Controla el juego.
- Decide qué ocurre y qué no.
- Impone reglas.
- Amenaza con retirarle algo al otro (amistad, aceptación, pertenencia).
- Observa la incomodidad y no detiene la conducta.

El abuso entre pares surge cuando un niño:

- Impone contacto sexual no deseado,
- Transgrede límites corporales sin permiso,
- Introduce conductas sexualizadas intrusivas,
- Utiliza fuerza física, emocional o simbólica.

Estas conductas no son “errores infantiles”: son señales de trauma, exposición o fallas adultas en contención y supervisión.

Casos con diferencia de edad (4 a 5 años o más): implicancias en consentimiento, madurez y coerción

Cuando hay una diferencia de edad de 4 o 5 años, ya no estamos en territorio ambiguo.

Por qué es tan relevante la diferencia de edad

Un niño de 12 años tiene:

- **Mayor fuerza,**
- **Mayor capacidad cognitiva,**
- **Mayor conocimiento sexual,**
- **Mayor habilidad para manipular u ocultar,**
- **Mayor comprensión del secreto y del poder.**

En comparación con un niño de 7 o 8 años:

- **Su capacidad de comprender, anticipar y consentir es limitada;**
- **Su pensamiento concreto no le permite dimensionar consecuencias;**
- **Su estructura emocional aún depende fuertemente del adulto para sentirse seguro.**

El consentimiento en estos casos es una ilusión

Cuando hay 4–5 años de diferencia, el consentimiento:

- **NO EXISTE,**
- **NO ES VÁLIDO,**
- **NO PUEDE EVALUARSE COMO ACUERDO MUTUO.**

El menor no tiene herramientas cognitivas ni emocionales para comprender lo que ocurre.

IMPLICANCIAS FORENSES

En una pericia, una diferencia de edad significativa:

Invalida la bilateralidad del acto

- Ubica automáticamente al niño mayor en rol de poder
- Genera presunción de coerción explícita o implícita.
- Incluso cuando no hay golpes ni amenazas, la diferencia de edad es en sí misma un factor coercitivo.

DINÁMICAS VINCULARES DE PODER Y SUMISIÓN ENTRE NIÑOS

El abuso entre pares no siempre es físico; muchas veces es relacional.

Las dinámicas que observamos son:

Liderazgo abusivo: “Vos hacé esto y después yo te dejo jugar conmigo”.

Imposición simbólica: “Si no querés, sos un bebé; no sos mi amigo.”

Seducción manipulativa: “Esto es un secreto entre nosotros, es porque te quiero.”

Aislamiento del otro: el niño mayor controla el acceso a otros compañeros.

- Dependencia emocional del niño más pequeño hacia el mayor.
- La sumisión infantil no es elección, es supervivencia vincular

Los niños más pequeños pueden:

- **Reírse nerviosamente,**
- **Seguir instrucciones sin entender,**
- **Congelarse,**
- **Complacer para evitar perder aprobación,**
- **Mantenerse en la situación por miedo a quedar solos.**

La sumisión emocional o vincular es tan seria como la coerción física.

Lo que se analiza en términos forenses

No se pregunta:

“¿El niño dijo que sí?”

Se pregunta:

“¿Tenía condiciones reales para decir que no?”

Variables de coerción, manipulación o intimidación

Las conductas abusivas entre pares no necesitan violencia explícita. La coerción infantil se expresa de múltiples maneras sutiles y potentes.

1. Coerción física

- Sujeción de manos
- Impedir que el otro se retire
- Bloquear la puerta o un camino

- Forzar posiciones corporales

2. Coerción emocional

- “Si no querés, me enojo contigo.”
- “Después no sos más mi amigo.”
- “Todos los demás hacen esto, sos vos el raro.”
- La coerción emocional es extremadamente frecuente en preadolescentes.

3. Manipulación afectiva

- “Es un juego especial.”
- “Es algo de amigos.”
- “Te voy a querer más si hacemos esto.”
- La manipulación afectiva genera un vínculo traumático.

4. Intimidación directa o indirecta

- Amenazas (“Voy a decir que vos empezaste”).
- Ridiculización.
- Chantaje.
- Uso del secreto: “Si contás algo, te va a ir mal.”

5. Intimidación simbólica

- Puede ejercerse incluso sin palabras:
- Miradas intimidantes
- Gestos de autoridad
- Aproximaciones invasivas
- Control del espacio físico

6. Intimidación digital

Hoy, la coerción se amplifica con:

- Fotos,
- Retos,
- Mensajes privados,
- Presión grupal online.

La intimidación digital puede ser más devastadora que la presencial debido a:

- Permanencia de la evidencia
- Humillación

- Imposibilidad de “escapar” del espacio virtual

MIRADA DE UN PERITO PSICÓLOGO:

CÓMO SE LEE LA CONDUCTA ABUSIVA ENTRE PARES

Desde el enfoque forense:

- No se analiza “si hubo penetración”, sino si hubo violación del límite del otro.
- No se evalúa “si el niño entendió”, sino si tenía capacidad para entender.
- No se pregunta “si quiso o no quiso”, sino si podía querer.
- No se interpreta el acto como sexualidad infantil, sino como asimetría emocional, cognitiva, física y simbólica.

El objetivo es desarmar la escena, leer la dinámica, reconstruir el sentido y determinar:

- Qué función cumplió la conducta para cada niño,
- Qué vulnerabilidades estaban operando,
- Qué riesgos emergen a futuro,
- Y qué intervenciones corresponden.

“El abuso entre pares no se define por el acto en sí, sino por la dinámica de poder que lo sostiene.”

El análisis forense debe iluminar esa dinámica, proteger al niño y comprender el sufrimiento detrás del gesto

CRITERIOS DIFERENCIALES ENTRE JUEGO, CURIOSIDAD Y ABUSO SEXUAL ENTRE PARES

Cómo pensar, más que reaccionar, cuando un niño presenta conductas sexualizadas.

Por qué es crucial diferenciar

En clínica, escuela y ámbito judicial, muchas veces se mezclan tres fenómenos distintos:

- Juego exploratorio → parte del desarrollo.
- Curiosidad sexual → necesidad de saber, preguntar, comprender.
- Abuso sexual entre pares → vulneración de límites, asimetría y daño.

Si los confundimos: **podemos criminalizar la infancia, o minimizar situaciones gravísimas bajo la frase: “son cosas de niños”.**

El rol del profesional es introducir matices, contexto y lectura técnica.

JUEGO EXPLORATORIO: EL LENGUAJE DEL CUERPO DENTRO DEL JUEGO SIMBÓLICO

El juego exploratorio es una de las formas más primitivas de conocimiento corporal y vincular.

Características centrales del juego exploratorio saludable

→ **Reciprocidad espontánea:**

Ambos niños participan, se ríen, se sorprenden, y pueden retirarse sin conflicto.

→ **Simetría**

Son de edades y capacidades similares. No hay un “líder” que decide todo.

→ **Duración breve y episódica**

Aparece, genera curiosidad, y luego el juego continúa con otra temática.

→ **Integrado en un juego más amplio**

No se arma “para tocar genitales”, sino dentro de jugar al médico, a la familia, a la escuela, etc.

→ **No hay secreto estructurado**

Puede haber pudor, pero no hay amenazas, pactos de silencio, miedo a que un adulto se entere.

→ **No genera síntomas posteriores**

El niño no queda angustiado, no evita al otro, no se desregula a partir de ese evento.

“En el juego exploratorio, el cuerpo es un personaje más del juego.”

CURIOSIDAD SEXUAL INFANTIL: PREGUNTAS QUE BUSCAN REPRESENTACIÓN, NO EXCITACIÓN

La curiosidad sexual no es conducta, es pregunta.

Muchos niños no actúan nada, pero preguntan mucho.

¿Cómo se manifiesta la curiosidad sexual evolutiva?

Preguntas del tipo:

- “¿Cómo nacen los bebés?”
- “¿Por qué vos tenés pene y yo vulva?”
- “¿Qué es hacer el amor?”

Quieren mirar, saber, nombrar, no necesariamente tocar.

No hay compulsión, sino búsqueda de información.

Pueden aparecer conductas como:

- Querer ver el cuerpo desnudo del otro,
- Comentar partes del cuerpo,
- Dibujar pares, embarazos, etc.

La curiosidad es un pedido de adultos disponibles, no motivo de alarma automática.

CRITERIO CLÍNICO CLAVE:

La curiosidad disminuye cuando el adulto responde con calma, claridad y límite.

Si aumenta en intensidad, se rigidiza o pasa al acto compulsivo, ya no estamos sólo ante curiosidad.

Comparando de forma práctica: tres lentes para mirar la misma escena:

Imaginemos la misma escena básica: dos niños en el baño de la escuela, uno propone mirar el cuerpo del otro.

Si es juego exploratorio:

- Ambos se ríen, miran, comparan, paran solos;
- Después siguen jugando a otra cosa;
- Lo recuerdan como algo gracioso o neutro;
- No hay diferencia marcada de edad o poder.

Si es curiosidad sexual:

- Tal vez uno pregunta más, mira, se sorprende;
- Pueden preguntar luego a un adulto;
- No hay secreto amenazante ni guion repetitivo;
- Si se les dice “esto no, es privado”, aceptan sin desorganizarse.

Si es CPS entre pares:

- Uno insiste aunque el otro no quiere o duda;
- Controla la puerta, el tiempo, la situación;
- Puede tocar o pedir que lo toquen contra la voluntad;
- Luego impone que nadie se entere;
- El niño sometido muestra malestar, evitación, angustia.

PREGUNTAS CLAVE PARA EL PROFESIONAL (CHECKLIST CLÍNICO-FORENSE)

En vez de quedarse sólo con el “qué pasó”, el profesional puede orientarse con estas preguntas:

¿Había simetría o asimetría entre los niños?

Edad, tamaño, fuerza, habilidades sociales, rol en el grupo.

¿El encuentro fue lúdico o tenso?

Risa, curiosidad, flexibilidad... o miedo, congelamiento, incomodidad.

¿Se podía decir que no?

¿Había condiciones reales para retirarse, negarse, irse de la situación?

¿Hubo secreto impuesto o amenazas?

El secreto por vergüenza no es lo mismo que el secreto bajo intimidación.

¿Qué pasó después?

¿Hubo cambios de conducta, regresiones, desregulación, evitación, síntomas?

¿La conducta fue única o repetida?

¿Fue un episodio aislado o una dinámica establecida en el vínculo?

“No todo juego con el cuerpo es CSP, y no toda CPS se parece a lo que imaginamos como violación.

La clave no está sólo en el acto, sino en la dinámica de poder, el consentimiento posible y el impacto subjetivo en cada niño.

Nuestro trabajo no es etiquetar rápido, sino pensar fino: diferenciar juego, curiosidad y CSP para proteger sin criminalizar, y cuidar sin banalizar.”

LA ENTREVISTA PSICOFORENSE EN INFANCIA:

Cómo Entrevistar y Qué No Hacer

Introducción: La Entrevista Psicoforense como herramienta de protección y verdad

La entrevista Psicoforense es un dispositivo técnico especializado cuyo objetivo no es “descubrir la verdad”, sino evaluar la calidad, coherencia y plausibilidad del relato del niño, garantizando su integridad emocional.



No es una entrevista clínica.



No es una entrevista terapéutica.



No es una entrevista policial.

Es un acto técnico protector, apoyado en principios de psicotraumatología, teoría del apego, neuropsicología infantil y modelos de evaluación criteriológica.

Premisa central

**“Una mala entrevista puede destruir un caso.
Una buena entrevista puede proteger una vida.”**

NATURALEZA DE LA ENTREVISTA PSICOFORENSE

La entrevista psicoforense:

- Recoge información de manera no sugestiva,
- Respeta la narrativa espontánea del niño,
- Evita revictimizar,
- Cuida la memoria traumática,
- Se centra en comprender cómo narra el niño,
- Busca indicadores de credibilidad, no “verdades absolutas”.

Es un proceso, no un interrogatorio

La entrevista psicoforense es un encuentro donde el profesional:

- **Acompaña,**
- **Observa,**
- **Facilita,**
- **No apura,**
- **No dirige,**
- **No juzga.**

No es un examen, ni un test de coherencia moral. Es un espacio donde el niño pueda narrar —**en la medida de sus posibilidades subjetivas**— aquello que vivió o que lo afecta.

Cómo entrevistar en Psicoforensia Infantil

A continuación, se desarrolla el modelo ideal paso a paso, propio de un trabajo técnico de excelencia.

→ Preparación del espacio y del profesional

Antes de comenzar: revisar el expediente sin contaminarse con hipótesis rígidas, dominar protocolos (GEA, NICHHD, CBCA), preparar una sala calma, segura, sin distractores,

- Disponer de juguetes neutrales (figuras, casas, animales, no muñecos eróticos), evaluar la edad, capacidad de simbolización y lenguaje del niño.

El profesional debe llegar:

- Regulado emocionalmente,
- Sin expectativas confirmatorias,

→ Sin ansiedad por “sacar información”.

INICIO DE LA ENTREVISTA

→ Vinculación inicial sin presión

→ El niño necesita sentir que el adulto no lo va a invadir.

Se busca:

→ Presentar el espacio,

→ Explicar la dinámica (“vos contás lo que quieras, yo escucho”),

→ Establecer reglas claras (“si no querés hablar de algo, está bien; lo importante es que estés seguro.”).

→ Nunca prometer confidencialidad total

→ Se explica que algunas cosas deben ser informadas para protegerlo.

DESARROLLO: ESCUCHA ACTIVA Y NARRATIVA ESPONTÁNEA

Preguntas amplias y abiertas

- “¿Qué te gustaría contarme hoy?”
- “¿Qué te acordás de lo que pasó?”
- “¿Qué fue lo que te trajo hasta acá?”

→ **No se dirige el contenido.**

No se sobreinterroga.

No se adivina.

Tiempo, pausa y silencio

El silencio no es fracaso.

Es parte del proceso traumático.

Dejar que el niño:

- Respire,
- Piense,
- Juegue,
- Acomode mentalmente su memoria.

USO DEL JUEGO COMO CANAL NARRATIVO

El juego no es para “hacer hablar”, sino para:

- Observar roles,
- Ver repeticiones,
- Mirar cómo organiza el niño la escena,
- Identificar posiciones (dominador/dominado),
- Captar intrusiones o escenas compulsivas.

El juego ofrece la verdad emocional, no el detalle literal.

Observación clínica fina

Durante la entrevista se observan:

- **Cambios en la respiración,**
- **Microgestos,**
- **Evitaciones,**
- **Agresión desplazada,**
- **Repetición simbólica,**
- **Congelamiento,**
- **Hiperalerta,**
- **Desorganización durante ciertos temas.**

La narrativa traumática es fragmentada, sensorial, a veces contradictoria.

La narrativa inventada es lineal, estable, sin afecto o demasiado prolija.

El perito debe leer la corporalidad tanto como las palabras.

CIERRE DE LA ENTREVISTA

El cierre debe ser:

- Suave,
- Contenedor,
- Sin reforzar trauma,
- Sin felicitar por lo dicho,
- Sin validar contenido traumático como “verdad absoluta”.
- Se agradece la disposición del niño y se le restituye sensación de control.

QUÉ NO HACER EN UNA ENTREVISTA PSICOFORENSE

Este apartado es crucial. Lo que no debe hacerse jamás.

NO sugerir, NO inducir, NO completar

Ejemplos peligrosos:

“¿Te tocó allá abajo?”

“¿Fue tu padrastro el que hizo eso?”

“¿Estás seguro que no hizo algo más?”

“Mostrame cómo pasó.”

Estas preguntas instalan información que el niño no dijo.

NO repetir la misma pregunta

- La repetición:
- Instala duda,
- Genera presión,
- Induce respuestas deseadas.

Un niño, frente a la insistencia, completa lo que cree que el adulto espera.

NO elogiar el contenido traumático

Nunca decir:

- “¡Qué valiente por contar eso!”
- “Muy bien lo que dijiste.”

Esto refuerza la respuesta traumática hablada y puede inducir ampliación artificial.

NO someter al niño a interrogatorios múltiples

La multiplicación de entrevistas genera:

- Contaminación,
- Confusión,
- Desgaste,
- Memoria reconstruida,
- Mayor riesgo de error.

El niño no debe repetir su historia 5 veces: debe narrarla una vez, bien, en un contexto protegido.

NO usar lenguaje adulto, técnico o judicial

No decir:

- “Violación”,
- “Penetración”,
- “abuso”,
- “pericia”,
- “hechos”,
- “denuncia”.

El niño no entiende esos términos y puede adaptarse a ellos.

- NO corregir al niño

FRASES PROHIBIDAS:

- “Así no fue, ¿no?”
- “Eso no puede haber pasado.”
- “¿No será que te equivocaste?”

→ La corrección destruye la confianza y modifica el relato.

NO DERIVAR EMOCIONES DEL NIÑO HACIA LA CULPA O VERGÜENZA:

No decir:

- “¿Por qué no lo dijiste antes?”
- “¿Por qué dejaste que pasara?”
- “¿Vos sabías que eso estaba mal?”
- Esto revictimiza y desestructura.

NO INTERPRETAR LITERALMENTE EL JUEGO

- El juego no es confesión.
Es representación simbólica.
- Interpretar literalmente una escena simbólica puede ser un grave error pericial.

PRINCIPIO RECTOR:

EL “MEJOR INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO”

La entrevista psicoforense debe ajustarse siempre a este principio internacional.

- NO dañar,
- NO presionar,
- NO usar al niño como instrumento judicial,
- NO buscar confesiones,
- Proteger su salud psíquica antes que cualquier objetivo procesal.
- La ética por encima del expediente
- “Antes que el caso, está el niño. Antes que la verdad jurídica, está su verdad psíquica.”

El objetivo de la entrevista psicoforense no es obtener un relato perfecto, sino un relato cuidado. No se trata de hacer hablar al niño, sino de acompañarlo a narrar sin contaminar su memoria, sin presionarlo y sin dañarlo.

El buen perito no busca respuestas: **crea condiciones para que las respuestas emerjan**

Intervención Clínica y Psicosocial

“Intervenir sin dañar: restaurar, contener, proteger.”

La intervención en casos de conductas sexualizadas problemáticas (CSP) o conductas abusivas entre pares no es un tratamiento tradicional: **es un dispositivo clínico-ecológico que articula psicoterapia, trabajo familiar, acompañamiento escolar e intervención comunitaria.**

El foco no es “culpar” ni “etiquetar”, sino proteger, restaurar, reestructurar y educar.

CÓMO INTERVENIR SIN REVICTIMIZAR NI PATOLOGIZAR

No revictimizar: intervenir cuidando la memoria traumática

Para no revictimizar al niño:

- Evitar interrogatorios repetidos.
- Evitar que cuente la escena traumática múltiples veces.
- Evitar exponerlo en reuniones entre adultos.
- Evitar interpretaciones moralizantes o judicializantes.
- Sustituir el “¿Qué pasó?” por “¿Cómo te sentís?”
- Acompañar sin pedir detalles innecesarios.
- Validar su experiencia emocional (miedo, vergüenza, confusión).

No patologizar: diferenciar síntoma de identidad

El niño que presenta CSP no es un abusador adulto.
El niño que fue victimizado no es una víctima eterna.
Ambos necesitan tratamiento, no etiquetas.

Evitar frases como:

- “Se volvió abusador.”
- “Va a repetir esto en el futuro.”
- “Es un niño sexualizado.”

La intervención se basa en una premisa clave:

La conducta es un síntoma. No es la identidad del niño.

Acompañamiento clínico delicado

Se centra en:

- Regulación emocional,
- Trabajo sobre el cuerpo,
- Integración simbólica,
- Reparación interna,
- Restitución de control,
- Reconstrucción de límites,
- Fortalecimiento del apego seguro.

**ESTRATEGIAS CON EL NIÑO QUE EJERCIO LA
CONDUCTA: ENFOQUE RESTAURATIVO, EMPÁTICO Y
EDUCATIVO**



**El niño que ejerció la conducta no debe ser tratado
como un agresor adulto.**

**Debe ser tratado como un niño en vulnerabilidad que
actuó desde desregulación, imitación o trauma.**

ENFOQUE RESTAURATIVO

El objetivo es:

- Comprender el impacto,
- Asumir responsabilidad desde el marco evolutivo,
- Reparar el vínculo si es adecuado,
- Restituir límites protectores,
- Evitar la repetición futura.
- En el enfoque restaurativo:
 - Se explica el daño sin culpar,
 - Se muestra cómo se sintió el otro,
 - Se reestablecen reglas claras,
 - Se construyen alternativas de relación no abusivas.
 - Intervención empática

Con el niño que ejerció la conducta se trabaja:

- Regulación emocional (respirar, sentir, nombrar),
- Lectura de emociones ajenas (empatía básica),
- Límite corporal ("cómo sé que el otro quiere o no quiere"),
- Habilidades sociales,
- Control de impulsos,
- Comprensión del consentimiento,
- Reconstrucción del sentido del cuerpo propio.

Intervención psico educativa

- Que el cuerpo propio es privado,
- Que el cuerpo del otro también lo es,
- Qué es un límite,
- Cómo se dice "no" y cómo se escucha "no",
- Qué es un secreto sano y qué es un secreto peligroso,
- Cómo lidiar con la curiosidad sexual de manera evolutiva.

El objetivo no es castigar: es transformar.

Trabajo con las familias y escuelas: contención, reparación y límites protectores

El entorno adulto es clave. Ninguna intervención clínica funciona sin un sostén psicosocial adecuado.

Trabajo con familias

1. Contención emocional

Las familias necesitan:

- Información clara,
- Orientación técnica,
- Bajar la culpa,
- Entender qué es una CSP y qué no,
- Aprender a regular sus propias emociones para no transmitir angustia al niño.

2. Reparación relacional

- Permitir que la familia:
- Se reorganice,
- Sostenga al niño,
- Ubique límites saludables,
- Genere un clima emocional seguro.

3. Límites protectores

Incluir:

- Supervisión adecuada,
- Evitar contactos riesgosos,
- Reglas claras en casa,
- Acompañamiento al baño,
- Regulares dispositivos electrónicos,
- Evitar exposición pornográfica,
- Prohibir juegos invasivos.

4. Trabajo sobre la parentalidad

Muchos padres carecen de herramientas para:

- Hablar de sexualidad,
- Sostener límites,
- Detectar riesgos,
- Interpretar señales.
- El profesional debe psico educar, acompañar y fortalecer funciones parentales.

B. Trabajo con escuelas

La escuela es un escenario privilegiado para la intervención. Involucra:

1. Contención institucional

- Sostener emocionalmente al niño,
- Evitar sanciones humillantes,
- Brindar adultos significativos disponibles.

2. Restauración grupal

El grupo de compañeros puede:

- Estigmatizar,
- Repetir rumores,
- Excluir.
- Se trabaja con el salón para:
- Frenar hostigamiento,
- Promover cuidado mutuo,
- Restablecer límites simbólicos.

3. Protocolos claros

La escuela debe:

- Registrar,
- Informar al referente adulto,
- Activar protocolo de protección y Mapa de Ruta
- Evitar mediaciones entre niños y familias,
- Asegurar privacidad.

4. Intervención pedagógica

Integrar contenidos sobre:

- Autocuidado,
- Consentimiento,
- Límites,
- Convivencia.

Coordinación interinstitucional (educación, salud, INAU, justicia)

Este es uno de los puntos más importantes.

El profesional debe ser un articulador técnico entre:

- Escuela o institución educativa
- Sistema de salud (psicología, pediatría, psiquiatría)
- INAU – SIPIAV
- Juzgados de Familia o Penal
- Equipos territoriales (ETAF, MIDES, etc.)

Objetivo central

**“Sin red, el niño queda solo.
Con una red coordinada, el niño
queda protegido.”**

EDUCACIÓN

Proveer información clara y orientaciones prácticas:

- Supervisión,
- Límites,
- Apoyo emocional,
- Registro adecuado.

SALUD

Coordinación con:

- Pediatría (lesiones, síntomas somáticos),

- Psiquiatría infantil (regulación, medicación si es necesaria),
- Psicoterapia especializada (trauma, apego, conducta).
- Inau / SIPIAV

Informar condiciones de riesgo:

- Negligencia,
- Abandono,
- Exposición,
- Violencia.
- Activar rutas de protección.

JUSTICIA

Cuando corresponda:

- Informes periciales,
- Medidas cautelares,
- Restricciones de contacto,
- Recomendaciones de seguridad.

El objetivo no es judicializar: es proteger.

Intervenir en una conducta sexualizada infantil no es intervenir en la sexualidad: es intervenir en el vínculo, en la regulación, en la protección y en la reparación.

El niño que ejerció necesita límites y contención.
El niño que vivió la intrusión necesita seguridad y sostén.
Las familias necesitan orientación.
La escuela necesita herramientas.
La sociedad necesita responsabilidad.

La intervención clínica y psicosocial no busca castigar: busca sanar.

PROTOCOLOS, ÉTICA Y TOMA DE DECISIONES EN CASOS DE CONDUCTAS SEXUALIZADAS ENTRE PARES

“Responder con rigor, intervenir con sensibilidad, proteger sin dañar.”

Este módulo integra el plano procedimental, ético, clínico y forense, para guiar decisiones de alto impacto en contextos educativos, familiares y judiciales.

¿Cuándo intervenir? Criterios de alarma y riesgo

- No todas las conductas sexualizadas requieren denuncia.
- No todas requieren pericia inmediata.
- Pero sí todas requieren lectura profesional.

A. Señales de bajo riesgo (intervención educativa y de contención)

- Conductas exploratorias recíprocas.
- Curiosidad anatómica entre pares de igual edad.
- Conductas esporádicas, sin compulsión.
- Niños sin angustia posterior.

Aquí se trabaja con:

- Psicoeducación,
- Límites,
- Supervisión,
- Orientación familiar.

B. Señales de riesgo moderado (intervención clínica y psicosocial)

- Conductas repetidas o intrusivas.
- Asimetría leve entre niños.
- Uno insiste, el otro duda.
- Angustia moderada.
- Exposición a pornografía.

→ Juegos de “secretos”.

Aquí se requiere:

- Evaluación clínica especializada,
- Trabajo escolar,
- Límites protectores,
- Orientación familiar intensiva.

C. Señales de alto riesgo (denuncia, pericia, medidas de protección)

- Diferencia de edad significativa.
- Coerción, intimidación, manipulación.
- Conductas sexuales intrusivas o agresivas.
- Niños con trauma previo.
- Sospecha de abuso sexual adulto en el origen.
- Daño emocional severo o síntomas graves.

Aquí corresponde:

- Activar SIPIAV,
- Informar a INAU,
- Evaluar pericia forense,
- Implementar medidas judiciales si corresponde,
- Coordinar salud-educación-justicia.

Protocolo de acción institucional

Este protocolo es fundamental para escuelas, jardines, liceos y centros educativos.

Paso 1: Detección

- Un docente observa, escucha, o un niño revela algo.
 - No juzgar.
 - No interrogar.
 - No minimizar.
 - Registrar exactamente lo expresado.

Paso 2: Contención inmediata

- Separar a los niños sin confrontarlos.
- Asegurar calma.
- No exponerlos frente a otros.
- Validar emociones sin sugerir contenido.

Paso 3: Comunicación interna

- Solo con autoridades habilitadas
- Dirección, Inspección
- Equipo psicosocial,

Nunca con otros docentes no involucrados. Jamás con otros padres o con el grupo escolar.

Paso 4: Información a la familia

- Mostrar:
- Calma,
- Claridad,
- Marco protector.
- No culpar.
- No acusar.
- No presentar hipótesis cerradas.

Paso 5: Activación del protocolo externo

- Según gravedad:
- Equipo de salud mental,
- INAU – SIPIAV,
- Juzgado de Familia o Penal Adolescente,
- Pediatra/psiquiatría infantil si hay síntomas severos.

ÉTICA PROFESIONAL: PRINCIPIOS RECTORES

Este apartado es clave para profesionales, escuelas, psicólogos y operadores judiciales.

A. Principio de No Daño

La intervención no debe generar más daño que la conducta original.

Evitar:

- Interrogatorios repetidos,
- Exposición excesiva del niño,
- Lenguaje adulto,
- Interpretaciones moralizantes.

B. Principio de Veracidad Procedimental

El profesional no busca “creer” o “no creer”: busca evaluar con criterios técnicos (CBCA, GEA, coherencia narrativa, memoria). La fe no es método; el rigor sí.

C. Principio de Acompañamiento sensible

El niño debe sentirse visto, no utilizado como evidencia judicial.

D. Principio de Proporcionalidad

No todas las situaciones exigen la misma respuesta. La intervención debe ser proporcional al nivel de riesgo.

E. Principio de Confidencialidad Responsable

No es absoluto: el niño debe saber que algunas cosas se comparten para protegerlo, no para “acusarlo”.

TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS:

CÓMO DETERMINAR QUÉ NECESITA CADA NIÑO

A. Si el niño presenta CSP pero no hay abuso de poder

El objetivo es:

- Regulación emocional,
- Psicoeducación,
- Límites corporales,
- Acompañamiento parental,
- Control de exposición digital.

B. Si hubo abuso de poder entre pares

- El objetivo es doble:
- Proteger al niño vulnerado,
- Intervenir restaurativamente con el niño que ejerció.

C. Si la conducta sugiere posible abuso sexual adulto

Se debe activar:

- Evaluación clínica especializada,
- Protocolos legales,
- Protección integral inmediata.
- El niño puede mostrar CSP como señal, no como causa.

TOMA DE DECISIONES INSTITUCIONALES

A. Medidas de seguridad

- Rutinas de supervisión.
- Acompañamiento adulto.
- Evitar exposiciones innecesarias.

B. Intervenciones pedagógicas grupales

- Educación emocional.
- Respeto por el cuerpo.
- Consentimiento.
- Límites.

→ Derechos del niño.

C. Registro adecuado

Técnico, descriptivo, sin juicios ni interpretación.

D. Coordinación interinstitucional

Porque ninguna institución puede sola.

JUSTICIA Y DECISIONES LEGALES: CUÁNDO Y CÓMO

A. ¿Cuándo judicializar?

- Peligro grave,
- Daño emocional severo,
- Sospecha de abuso sexual adulto,
- Coerción significativa,
- Repetición de conductas agresivas.

B. Cómo judicializar sin dañar

- Con información clara,
- Con documentos técnicos,
- Sin exponer al niño,
- Sin generar conflicto familiar innecesario.

C. Rol del técnico

- Evaluar credibilidad,
- Determinar impacto,
- Recomendar medidas,
- Colaborar con Inau,
- Proteger al niño siempre por encima del proceso.

“No intervenimos para señalar culpables, sino para restaurar.

No intervenimos para castigar, sino para proteger.

No intervenimos para imponer un relato, sino para escuchar.

La ética es nuestro cuerpo teórico; la sensibilidad es nuestra herramienta clínica; y el niño, siempre, nuestra prioridad absoluta.”

INTEGRACIÓN CLÍNICA, FORENSE Y COMUNITARIA

“Cómo pensar, intervenir y sostener el fenómeno de las conductas sexualizadas desde una mirada sistémica y protectora.”

Este módulo da forma al cierre de la Masterclass: deja al profesional con criterios claros, mirada ética, herramientas prácticas y un mapa completo del fenómeno.

- Comprender el fenómeno como un sistema: nunca es un niño solo
- Las conductas sexualizadas entre pares no surgen en el vacío.

Surgen en un ecosistema emocional compuesto por:

- Dinámicas familiares,
- Contextos escolares,
- Exposición digital,
- Modelos vinculares,
- Eventos traumáticos,
- Fallas de supervisión,
- Presión de pares,
- Cultura hipersexualizada.

“No evaluamos la conducta en sí, sino la red que la sostiene.”

El profesional debe leer:

- La historia del niño,
- La historia de su familia,
- El contexto escolar,

- Los modelos internos de relación,
- Las heridas previas no elaboradas,
- Los límites difusos o inexistentes.

LA TRÍADA DE ORO: CUERPO – RELATO – CONTEXTO

Una evaluación completa debe integrar tres niveles:

A. El cuerpo

El cuerpo revela trauma

- Hiperalerta,
- Evitación,
- Desregulación,
- Congelamiento,
- Tensión muscular,
- Sexualización temprana,
- Regresiones.

B. El relato

El relato revela memoria:

- Fragmentación,
- Sensoriedad,
- Contradicciones traumáticas,
- Afecto incongruente,
- Rigidez narrativa (memoria inducida).

C. El contexto

El contexto revela riesgo:

- Negligencia,
- Exposición,
- Violencia,
- Vínculos invasivos,
- Secretos,
- Dinámicas coercitivas,
- Pornografía.

El profesional integra los tres planos, no sólo uno.

El doble foco del cuidado: Protección + Reparación

La intervención en CSP o abuso entre pares debe cumplir un doble objetivo:

1. Proteger

- Evitar repetición,
- Supervisión adulta,
- Límites claros,
- Medidas institucionales,
- Acompañamiento psicosocial,
- Contención afectiva.

2. Reparar

- Sanar la memoria traumática,
- Fortalecer la autoimagen,
- Restaurar la capacidad de confiar,
- Reparar vínculos dañados,
- Reenseñar límites y consentimiento,
- Trabajar el cuerpo como espacio seguro.

**“Proteger sin reparar es insuficiente.
Reparar sin proteger es peligroso.”**

LA VOZ DEL NIÑO: CENTRALIDAD SUBJETIVA Y RESPECTO POR SU PERSPECTIVA

El niño no es sólo un sujeto a evaluar, sino un sujeto a escuchar, incluso cuando no puede narrar plenamente lo ocurrido.

A. Validación emocional

- “Lo que sentís importa.”
- “Tu cuerpo importa.”
- “Tus sensaciones son señales que escuchamos.”

B. Participación progresiva

El niño debe sentir que:

- Tiene derecho a hablar,
- Tiene derecho a callar,
- Tiene derecho a entender,
- Tiene derecho a ser protegido,
- Tiene derecho a pedir ayuda.

C. No imponer narrativa adulta

- Ni suponer motivaciones,
- Ni presionar para recordar,
- Ni corregir lo dicho.

La subjetividad del niño es única, no intercambiable.

Dimensión emocional del profesional: Autocuidado, supervisión y regulación

Este trabajo duele, cansa y desregula.

El profesional que aborda CSP necesita:

A. Supervisión clínica continua

Para:

- Pensar las escenas,
- Desarmar transferencias,
- Evitar sobreinvolucramiento,
- Sostener casos graves.

B. Autocuidado

- Descanso,
- Límites claros,
- Pausas entre sesiones,
- Rituales de cierre laboral,
- Actividad física o reguladora.

C. Regulación propia

No entrevistar ni intervenir desde:

- La ansiedad,
- El enojo,
- La confusión,
- El juicio moral.

“Un adulto desregulado no puede regular a un niño desregulado.”

IMPACTO COMUNITARIO Y PREVENCIÓN: EL ROL SOCIAL DEL PSICÓLOGO

Las conductas sexualizadas entre pares no se abordan sólo con clínica individual.

Requieren estrategias comunitarias, porque el fenómeno es social.

A. Prevención escolar

- Programas de autocuidado,
- Educación sexual integral (apropiada a la edad),
- Formación docente en límites y escucha,
- Regulación digital en las aulas.

B. Formación a familias

- Enseñar límites,
- Enseñar sobre consentimiento,
- Acompañar a hijos en el mundo digital,
- Evitar la negligencia emocional.

C. Sensibilización comunitaria

- Desmitificar la sexualidad infantil,
- Evitar la criminalización precoz,
- Promover redes de protección.

LA MIRADA DEL PERITO:

INTEGRIDAD, PRUDENCIA Y HUMANIDAD

El perito forense debe ser:

- Firme sin ser rígido,
- Sensible sin ser ingenuo,
- Crítico sin ser destructivo,
- Técnico sin ser deshumanizado.

Tres preguntas finales del perito experto

¿Qué sostiene esta conducta?

Trauma, exposición, negligencia, coerción, desregulación...

¿Qué necesita este niño hoy?

Protección, contención, regulación, escucha, intervención clínica...

¿Qué decisiones garantizan su bienestar futuro?

Intervención psicosocial, trabajo familiar, supervisión escolar, apoyo judicial...

ENTONCES:

Los niños exploran, preguntan, buscan, juegan. Pero también pueden repetir, actuar, sobrevivir o expresar en la piel lo que no pueden nombrar.

Las conductas sexualizadas entre pares no definen su identidad, pero sí nos convocan a responsabilizarnos como adultos.

Cuando intervenimos con claridad técnica, con humanidad profunda y con rigor ético, estamos haciendo algo más que resolver un caso: estamos cuidando el futuro emocional de un niño, de una familia y de una comunidad.

La protección es un acto clínico.

La reparación es un acto de amor profesional.

Y la prevención es un compromiso social.”

MÓDULO EXCLUSIVO — Victimología en la Infancia

“El niño como sujeto de vulneración, de significado y de supervivencia”

Perspectiva clínica, forense, psicotraumatológica y social.

Introducción victimológica: la víctima como experiencia, no como etiqueta

La victimología infantil no estudia el acto, sino LA EXPERIENCIA SUBJETIVA DEL NIÑO.

Un niño puede haber vivido una conducta sexualizada leve y quedar profundamente afectado. Otro puede haber atravesado una intrusión mayor y mostrar aparente adaptación.

Por eso, la pregunta victimológica central no es:

“¿Qué pasó?”

Sino

“¿Qué efecto tuvo en el niño lo que pasó?”

Esto cambia todo el enfoque clínico y forense.

CATEGORÍAS VICTIMOLÓGICAS APLICADAS A LA INFANCIA

Cómo leer el fenómeno con lentes diferenciadas.

Victimización primaria

Es el daño producido por el acto inicial:

- Intrusión corporal,
- Invasión del espacio psíquico,
- Coerción emocional,
- Asimetría de poder,
- Confusión o miedo.

Victimización secundaria

Es el daño producido por la reacción del entorno:

- Interrogatorios repetidos,
- Escuela que estigmatiza,
- Adultos que dudan o culpan,
- Ambientes judicializantes,
- Falta de protección adecuada.
- En muchos casos, el daño secundario es más devastador que el primario.

Victimización terciaria

Es el impacto a largo plazo:

- Autoimagen dañada,
- Vergüenza,
- Dificultades para confiar,
- Guiones vinculares traumáticos,
- Estigmatización social.

La intervención victimológica busca interrumpir este proceso.

- **Microvictimización: invasiones sutiles que afectan profundamente**

Los niños no sólo sufren daño cuando ocurre un acto intrusivo grave.

Existen **microvictimizaciones**, experiencias “pequeñas” desde el punto de vista del adulto, pero “gigantes” desde la subjetividad infantil:

Secretes impuestos,

Manipulación leve,

Risas, humillaciones, burlas,

Presión de pares,

Miradas intimidantes,

Vergüenza corporal,

Exposición a pornografía como shock emocional,

Contacto sexualizado no deseado, aunque mínimo.

La victimología moderna enseña que el cuerpo del niño no mide el daño: lo mide la vivencia interna.

NIÑO VÍCTIMA Y NIÑO AUTOR: LA PARADOJA VICTIMOLÓGICA

→ **Una de las ideas más avanzadas y disruptivas es la DUALIDAD VÍCTIMA-AUTOR.**

Muchos niños que ejercen una conducta sexualizada intrusiva:

- Imitan vivencias propias,
- Reproducen trauma previo,
- Repiten escenas internalizadas,
- Expresan negligencia afectiva,
- Buscan control porque no lo tuvieron,
- Reeditan su propia victimización.

En victimología, estos niños son llamados:

“VÍCTIMAS QUE ACTÚAN SU TRAUMA EN EL LUGAR DEL AGRESOR.”

Este concepto es clave para evitar la criminalización infantil.

Respuestas emocionales típicas de la víctima infantil

Las respuestas no siempre son obvias:

A. Hiperactivación (estrés traumático)

Miedo,

Sobresaltos,

Llanto,

Irritabilidad.

B. Inhibición

Silencio,

Retraimiento,

Mirada baja,

Congelamiento.

C. Disociación

Desconexión,

Falta de recuerdo,

Automatización,

Risas inmotivadas durante el relato.

D. Sexualización postrauma

Juegos sexualizados,

Dibujos intrusivos,

Preguntas insistentes,

Imitación de pornografía.

La victimología enseña que la sexualización posterior no es deseo, sino memoria traumática sin simbolizar.

FACTORES VICTIMÓGENOS: LO QUE VUELVE VULNERABLE A UN NIÑO

Los niños no “provocan” su victimización; son los entornos los que configuran vulnerabilidad.

Factores victimógenos típicos:

- Negligencia emocional crónica,
- Falta de supervisión,
- Vínculos con apego inseguro o desorganizado,
- Caos familiar,
- Violencia intrafamiliar,
- Exposición a pornografía,
- Aislamiento social,
- Dificultad para decir “no”,
- Dependencia emocional,
- Baja autoestima,
- Trauma previo.

La victimología ilumina que la vulnerabilidad surge donde el adulto falta.

Silencio victimológico: cuando el niño no puede hablar

El silencio infantil no es mentira; es supervivencia.

Los niños callan porque:

- Sienten culpa,
- Temen perder afectos,
- No entienden lo ocurrido,
- Tienen miedo a los adultos,
- No saben poner palabras,
- Experimentan disociación,
- No saben si lo que pasó “está bien o mal”.

Concepto clave:

“Callar no es negar.

**Callar es sobrevivir cuando no hay un
adulto seguro.”**

La reacción del entorno como factor agravante o protector

La victimología identifica dos trayectorias:

A. Trayectoria de daño

Cuando el entorno responde con:

- Culpa,
- Minimización,
- Negación,
- Sobreexposición,
- Inquisición,
- Ataques,
- Desborde emocional adulto.

B. Trayectoria de protección

Cuando el entorno responde con:

- Calma,
- Cuidado,
- Escucha,
- Contención,
- Límites protectores,
- Claridad,
- Decisión firme sin violencia.

**La diferencia no es el acto: es cómo los
adultos responden al acto.**

**REPARACIÓN VICTIMOLÓGICA: MÁS QUE
TRATAMIENTO, RESTITUCIÓN INTERNA**

La reparación victimológica incluye:

A. Restaurar la dignidad

“Lo que pasó no define tu valor.”

B. Reconstruir la agencia

“Podés decir no, podés elegir”.

C. Brindar un adulto protector

“Nadie te va a dejar solo con esto.”

D. Integrar la memoria

“No es tu culpa.

No hiciste nada mal.”

E. Reposicionar al niño en la comunidad

“No estás dañado.

No sos raro.

No quedaste marcado.”

F. Rehabilitar el cuerpo como lugar seguro

A través de psicoterapia corporal, juego, apego, presencia afectiva.

CIERRE

“La victimología nos recuerda que el trauma no está en el hecho, sino en lo que el hecho quiebra dentro del niño.

Nos muestra que un niño puede ser víctima sin que haya lesiones, y que puede ser victimario sólo porque está actuando su propio dolor.

Nos enseña que la protección comienza cuando dejamos de ver ‘culpas’ y empezamos a ver ‘heridas’.

El desafío no es diagnosticar: es restaurar dignidad, seguridad y pertenencia.

Y ese es, en esencia, el trabajo más humano que un psicólogo puede hacer.”

¡MUCHAS GRACIAS!
¡HASTA LA PROXIMA!
ABRAZO